

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PANDUAN PRAKTEK KLINIS (PPK) TINDAKAN RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA SUKOREJO TAHUN 2024
PERSALINAN PADA MULTI GESTASI	
Pengertian (Definisi)	Suatu kehamilan dengan dua janin atau lebih
Indikasi	Dilakukan bila memenuhi syarat per vaginam dan tidak ada kontra indikasi
Kontraindikasi	1. Mal presentasi 2. Didapatkan fetopelvic disproportion (berat badan janin > 3500gr) 3. Pada bekas <i>Sectio Caesarea</i> (SC) 4. Pada panggul sempit 5. Pada prematuritas 6. Pada <i>High Social Valuable Baby</i> (HSVB) 7. Pada primi tua 8. Pada <i>Bad Obstetrical History</i> (BOH) 9. Pada <i>fetal compromised</i>
Syarat Pemberian	1. Dilatasi serviks lengkap 2. Selaput ketuban telah pecah atau dilakukan amniotomi 3. Tidak ada fetopelvic disproportion 4. Tidak ada kelainan jalan lahir 5. Tidak ada kelainan janin
Persiapan	Persiapan pasien : – Persetujuan Tindakan Medik – Pemeriksaan darah lengkap, USG, Kardiotokografi Persiapan Alat – Bed ginekologi – Sarung tangan – Apron – Sepatu boot – Masker – <i>Google</i> – <i>Cap</i> – Partus Set – Lampu sorot – <i>Neonatal resuscitation table</i> – <i>Resuscitation set</i> – <i>Hecting set</i> – Stetoskop – Doppler – Doek steril Persiapan Bahan – S spuit 3 cc – S spuit 5 cc – Lidocain Amp – Saflon – <i>Povidone Iodine</i> – Kasa steril – Kapas steril – Oksigen Persiapan Penolong/operator : – <i>Informed consent</i> – Alat Pelindung Diri (APD) Cuci tangan 6 langkah
Prosedur Tindakan	• Menyambut dengan sopan, memperkenalkan diri, menyampaikan maksud dan tujuan, <i>Informed consent</i>

	secara lisan • Memastikan kelengkapan alat dan meletakkan secara ergonomis • Menjaga privasi dan memposisikan klien • Memakai APD (apron, cap, <i>google</i>, masker, sepatu) • Mencuci tangan dengan teknik 6 langkah dan memakai sarung tangan A. Kala Pembukaan (kala I) 1. Lakukan palpasi Leopold untuk memastikan kembali letak dan presentasi janin. Pakai sarung tangan! lakukan periksa dalam untuk kesesuaian dengan hasil palpasi. Perhatikan: - Jika janin Pertama (JP) presentasi kepala dan tidak ditemui penyulit lainnya upayakan persalinan pervaginam. - Jika Janin Pertama (JP) bukan presentasi kepala tetapi tanpa penyulit lainnya observasi dan pantau secara ketat apabila akan diselesaikan pervaginam. - Jika Janin Pertama (JP) bukan presentasi kepala dan disertai dengan penyulit lainnya pertimbangkan untuk terminasi per abdominam. 2. Nilai kondisi his dan penilaian dengan baik dan cermat untuk menentukan adanya inersia dan melakukan pemberian tetes oksitosin. B. Kala pengeluaran (kala II) I. Melahirkan janin Pertama (Presentasi Kepala) 1. Jika pembukaan sudah lengkap, beritahukan pada ibu bahwa proses pengeluaran akan segera berlangsung dan minta ibu untuk mengikuti instruksi penolong 2. Pada saat puncak his, minta ibu untuk mengedan sambil menarik lipat lutut. Bila His menghilang, minta ibu beristirahat dan bersiap untuk mengedan pada his berikutnya. Pimpin berulang kali hingga kepala turun ke dasar panggul. 3. Pada saat ibu mengedan dan kepala membuka vulva serta mendorong perineum, lakukan episiotomi mediolateralis (bila diperlukan). 4. Lahirkan kepala, bersihkan muka, hidung dan mulut bayi, kemudian lahirkan seluruh tubuh bayi sebagai mana pada persalinan spontan. 5. Serahkan bayi kepada dokter anak / perawat mahir anak yang bertugas. 6. Istirahatkan ibu, nilai kembali his dan lakukan periksa dalam ulangan untuk menilai presentasi dan posisi janin Kedua (JK). Perhatikan: Bila persalinan terhenti, macet atau tak maju, pertimbangkan untuk menyelesaikan persalinan dengan tindakan obstetric operatif (pervaginam atau per abdominam) disesuaikan dengan indikasi, kondisi ibu jjanin dan sumber dayatersedia. II. Melahirkan janin kedua (JK) 1. Setelah bayi Pertama lahir, segera lakukan pemeriksaan dalam untuk menilai a. Letak presentasi dan penurunan kepala. b. Keutuhan selaput ketuban. c. Adanya penyulit dari faktor janin (misalnya:
--	---

	prolapsus tali pusat atau gawat janin atau retensi anak kedua), faktor ibu (misalnya: inersia, kelelahan atau hysteria), faktor teknis (misalnya: tidak cakap panggul, kesenjangan ukuran instrument dan bagian terbawah janin dan sebagainya) 2. a. Janin Kedua Presentasi Kepala. Tunggu his kuat, tahan fundus uteri kemudian fiksasikan kepala janin agar masuk ke dalam pintu atas panggul, kemudian lakukan amniotomi. Perhatikan: Pastikan tidak ada tali pusat terkemuka saat amniotomi dilakukan. b. Janin Kedua bukan Presentasi Kepala Jika syarat memenuhi, lakukan versi luar 1. Jika berhasil lanjutkan persalian pervaginam 2. Kalau gagal lanjutkan dengan persalinan sungsang jika tidak adaindikasi kontra Perhatikan: Jika terjadi prolaps tali pusat dan syarat tindakan terpenuhi, lakukan terminasi perabdominam C. Kala Uri (Kala III) 1. Segera setelah bayi Kedua lahir berikan oksitosin drips 10 iu dan lakukan pengosongan kandung kemih. 2. Upayakan uterus berkontraksi dengan baik (lihat penatalaksanaan akti3 kala III) 3. Lahirkan plasenta dengan traksi terkontrol pada tali pusat. Bila belum berhasil, tunggu hingga tampak tanda pelepasan (separasi) plasenta. Jika setelah 30 menit plasenta belum lepas, lahirkan plasenta secara manual. 1. Setelah plasenta lahir, periksa kelengkapannya. Perhatikan kontraksi uterus dan bila diperlukan, beri uterotonika. 2. Perhatikan perdarahan yang terjadi dan eksplorasi kemungkinan laserasi pada jalan lahir. 3. Lakukan penjahitan episiotami (bila dilakukan). Setelah nilai jalan lahir dan pasang kasa yang dibasahi dengan larutan antiseptik pada tempat jahitan episiotami. 4. Kumpulkan instrument dan bahan pakai ke dalam tempat yang telah disediakan(larutan Klorin 0,5 %). Bersihkan dan lepaskan sarung tangan ke dalam wadahd ekontaminasi. Cuci tangan hingga lengan dengan sabun dan air. Keringkandengan handuk bersih dan kering. 5. Periksa dan catat tanda vital ibu kemudian cantumkan dalam status. catat dan tuliskan instruksi untuk kala IV dan pemantauan lanjutan. D. KALA IV 1. Pantau kontraksi uterus dan jumlah perdarahan selama 2 jam pasCapersalinan. jika tanda vital dan hasil pemantauan menunjukkan nilai yang normal, kenakan kasa pembalut dan pakaian kemudian bawa pasien ke ruangan
Komplikasi	1. Ruptura portio 2. Gawat janin 3. Laserasi perineum
Edukasi	Pasien disarankan untuk menunda kehamilan setelah 3 x siklus haid, setelah tindakan kuretase
Kriteria Pulang	2 hari perawatan
Tingkat Evidens	
Tingkat Rekomendasi	

Penelaah Kritis	1. dr. Santoso Rahardjo, Sp. OG 2. dr. Rudi Priyo Utomo, Sp. OG 3. dr. Mulyo Hadi Wibowo, Sp. OG
Indikator Tindakan	1. Mampu melakukan langkah langkah persalihan multi gestasi dengan benar dan berurut 2. Tidak didapatkan kelainan letak yang mempersulit proses persalinan.
Kepustakaan	1. Wiknjosastro GH, Saifuddin AB, Rachimhadhi T, editors. 2010. <i>Ilmu Bedah Kebidanan Sarwono Prawirohardjo</i>. Ed 6. Jakarta: Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo. 2. Cuningham FG, Leveno KJ, Bloom SL, Hauth JC, Rouse DJ, Spong CY. 2018. <i>Breech Delivery</i>. In: william obstetrics. 25theds. New York: McGraw-Hill Education

Pasuruan, 04 Juni 2024

Mengetahui,

Direktur RS Prima Husada Sukorejo

dr. Ifit Bagus Apriantono

	kurang berkaitan dengan								tergantung data
	NI.5.10.1								asesmen,
	Kekurangan intake Fe								kemungkinan saja
	NB-1.5								ada
	Kekeliruan pola makan								diagnosis
	2. Edukasi dan Konseling Gizi								
	Diet pasca partus normal / diet ibu menyusui tinggi energi dan tinggi protein sesuai dengan kebutuhan.								Edukasi gizi dapat dilakukan bersamaan dengan kunjungan awal, atau dapat juga dilakukan pada hari ke 4 atau hari ke 5 saat pasien akan pulang.
	3. Tata Laksana / Intervensi								
	a. Diet Tinggi Energi Tinggi								Bentuk Makanan, kebutuhan
	b. Memberikan makanan dan								
	4. Monitoring dan Evaluasi (Monitor Perkembangan Pasien)								
	a. Monitoring asupan makan								Sesuai dengan masalah gizi dan
	b. Monitoring antropometri								Mengacu pada
	c. Monitoring Biokimia								
	d. Monitoring fisik / klinis terkait gizi								
	5. Hasil								
	a. Asupan Makan >80%								Status gizi optimalisasi diet
	b. Optimalisasi status gizi								

KESIMPULAN :

Nama KaRu	
Kategori	TIDAK PATUH

Variasi yang menyebabkan anda tidak mematuhi CP :

FARMASI

KEGIATAN	URAIAN KEGIATAN	HARI PENYAKIT							KETERA NGAN
		1	2	3	4	5	6	7	
		HARI DIRAWAT							
		1	2	3	4	5	6	7	
1. Pengkajian Awal Asuhan	1. Data Subjektif								
	a. Riwayat Alergi Obat								

KESIMPULAN :		Variasi yang menyebabkan anda tidak mematuhi CP :	
Nama KaRu			
Kategori	TIDAK PATUH		

KEPERAWATAN									
KEGIATAN	URAIAN KEGIATAN	HARI PENYAKIT							KETERA NGAN
		1	2	3	4	5	6	7	
		HARI DIRAWAT							
		1	2	3	4	5	6	7	
1. Pengkajian awal keperawatan rawat inap	1.data subjektif								
	mengeluh nyeri								
	2.data objektif								
	protektif,gelisah,frekuensi								
2, Intervensi keperawatan	1. nyeri akut								
	akut								
	pemberian obat-obatan								
	(mis:tekanan darah								
	lokasi,karakteristik,durasi,frek								

	e. identifikasi skala nyeri								
	verbal								
	memperberat dan								
	dan keyakinan tentang nyeri								
	Terapeutik								
	nonfarmakologis untuk								
	memperberat rasa nyeri								
	c. fasilitas istirahat dan tidur								
	pemeriksaan darah lengkap								
	sumber nyeri dalam pemilihan								
	Edukasi								
	a. jelaskan								
	b. jelaskan strategi								
	c. Anjurkan memonitor nyeri								
	d. anjurkan teknik								
	Kolaborasi								
	analgetik,jika perlu								
	2.nausea								
	nausea								
	pemberian makanan								
	(mis:merasa asam								
	mual;								
	mual								
	mual(mis:frekuensi,durasi,dan								
	kalori								
	h. identifikasi dampak mual								
	Terapeutik								
	lingkungan penyebab								
	keadaan penyebab mual								
	jumlah kecil dan menarik								
	dingin,cairan bening,tidak								
	Edukasi								
	a. anjurkan istirahat dan tidur								
	b. anjurkan sering								
	c. Anjurkan makanan tinggi								
	d. ajarkan penggunaan teknik								
	Kolaborasi								
	a. Kolaborasi pemberian anti emetic								bila perlu

KESIMPULAN :

Nama KaRu	
Kategori	TIDAK PATUH

Variasi yang menyebabkan anda tidak mematuhi CP :